

CAPÍTULO 14.20

Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo

PERFIL EUNACOM 1.05.1.003

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Introducción a la EMTC

La **Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo (EMTC)** es una entidad clínica bien definida que se caracteriza por presentar una combinación de manifestaciones clínicas que se solapan entre diversas enfermedades autoinmunes sistémicas.

Se considera una "mezcla" o un híbrido que toma elementos de la **Artritis Reumatoide**, el **Lupus Eritematoso Sistémico (LES)**, la **Esclerosis Sistémica** (esclerodermia) y las miopatías inflamatorias (**Polimiositis** y **Dermatomiositis**). Su identificación es fundamental en reumatología, ya que, aunque comparte rasgos, posee un marcador serológico específico y un pronóstico particular.

NOTA CLÍNICA

La fisiopatología de la EMTC se centra en una respuesta autoinmune dirigida contra componentes del núcleo celular, específicamente contra la ribonucleoproteína. A diferencia del Lupus, donde la autoinmunidad es más amplia (Anti-DNA, Anti-Sm), en la EMTC la respuesta es muy dirigida, lo que define su perfil clínico único.

Manifestaciones Clínicas

La clínica de la EMTC es heterogénea debido a su naturaleza "mixta". Los síntomas pueden aparecer de forma simultánea o evolucionar secuencialmente a lo largo del tiempo.

1. Rasgos de Artritis Reumatoide

Es una de las manifestaciones más frecuentes. - **Artritis:** Generalmente es una poliartritis simétrica que afecta pequeñas articulaciones, muy similar a la AR, aunque suele ser menos erosiva en las radiografías.

2. Rasgos de Lupus Eritematoso Sistémico (LES)

La EMTC comparte múltiples criterios con el lupus: - **Mucocutáneo:** Presencia de úlceras orales y, en algunos casos, el **rash malar** característico. - **Serositis:** Es común encontrar pericarditis o pleuritis. - **Lupus cutáneo subagudo:** Lesiones anulares o psoriasiformes fotosensibles.

3. Rasgos de Esclerosis Sistémica

Son elementos pronósticos importantes y suelen ser los más precoces: - **Fenómeno de Raynaud:** Presente en la gran mayoría de los pacientes (casi el 100%). Suele ser severo. - **Disfagia:** Alteraciones de la motilidad esofágica por afectación del músculo liso. - **Esclerodactilia:** Engrosamiento y endurecimiento de la piel de los dedos (dedos "en salchicha" o "puffy hands").

4. Rasgos de Miopatías Inflamatorias

- **Miositis:** Debilidad muscular proximal simétrica y elevación de enzimas musculares (CK), similar a lo visto en la dermatomiositis o polimiositis.

5. Otras asociaciones

- **Síndrome de Sjögren:** Muchos pacientes desarrollan sequedad ocular y bucal (queratoconjuntivitis sicca) como complicación asociada.

TABLA 14.20.1: ENFERMEDAD QUE IMITA VS HALLAZGOS CLÍNICOS CLAVE EN EMTC

ENFERMEDAD QUE IMITA	HALLAZGOS CLÍNICOS CLAVE EN EMTC
Artritis Reumatoide	Poliartritis simétrica, dolor articular.
Lupus Eritematoso Sistémico (LES)	Úlceras orales, rash malar, pericarditis, leucopenia.
Esclerosis Sistémica	Fenómeno de Raynaud, dedos en salchicha, dismotilidad esofágica.
Polimiositis / Dermatomiositis	Debilidad muscular proximal, miositis.

Diagnóstico y Marcadores Serológicos

El diagnóstico de la EMTC se basa en la sospecha clínica ante un paciente con síntomas de varias conectivopatías, pero el pilar fundamental es el laboratorio inmunológico.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

El marcador diagnóstico más importante y "patognomónico" para el EUNACOM es la presencia de anticuerpos **Anti-ribonucleoproteína de tipo U1 (Anti-U1 RNP)** a títulos altos.

- **Anti-U1 RNP:** Su presencia en títulos elevados es el requisito indispensable para el diagnóstico. Si un paciente tiene Anti-Sm o Anti-DNA de doble cadena positivos, es mucho más probable que el diagnóstico sea **Lupus Eritematoso Sistémico (LES)** puro y no EMTC.
- **Factor Reumatoide:** Puede estar presente debido al componente de artritis.
- **ANA (Anticuerpos Antinucleares):** Suelen ser positivos con un patrón moteado (speckled).

Manejo y Tratamiento

El tratamiento de la EMTC no tiene un protocolo único, sino que se adapta a la manifestación predominante en cada paciente.

- **Similitud con el Lupus:** En general, el manejo farmacológico es muy similar al del **Lupus Eritematoso Sistémico (LES)**.
- **Corticoides:** Son la base para el manejo de la miositis, la serositis y las exacerbaciones de la artritis.
- **Hidroxicloroquina:** Útil para las manifestaciones cutáneas y articulares.
- **Inmunosupresores:** Se utilizan ahorradores de corticoides (como Metotrexato o Azatioprina) dependiendo del órgano afectado.
- **Vasodilatadores:** Para el manejo del fenómeno de Raynaud (ej. bloqueadores de canales de calcio).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Aunque el tratamiento es similar al del Lupus, se debe monitorizar estrechamente la aparición de **Hipertensión Pulmonar**, que es una de las principales causas de mortalidad en pacientes con EMTC y requiere un manejo especializado distinto.

Diagnóstico Diferencial: Conceptos Clave

Es fundamental no confundir la EMTC con otras situaciones de solapamiento clínico.

Síndrome de Sobreposición (Overlap)

Ocurre cuando un paciente cumple estrictamente los criterios diagnósticos de **dos o más enfermedades** definidas al mismo tiempo. Por ejemplo, un paciente que cumple todos los criterios de Lupus y todos los de Esclerosis Sistémica. En estos casos, el

manejo se ajusta según la complicación más grave de cualquiera de las dos patologías.

Enfermedad Indiferenciada del Tejido Conectivo (EITC)

Este es un concepto evolutivo: - Se refiere a pacientes que presentan síntomas y signos que sugieren una enfermedad autoinmune (ej. ANA positivo + Raynaud + artralgias), pero **no cumplen suficientes criterios** para ninguna enfermedad específica (ni para Lupus, ni para EMTC, ni para AR). - **Evolución:** Con el tiempo, un porcentaje importante de estos pacientes evoluciona hacia una enfermedad definida (frecuentemente Lupus o Esclerosis Sistémica). Otros permanecen como "indiferenciados" con una clínica leve y estable.

TABLA 14.20.2: CONCEPTO VS CARACTERÍSTICA PRINCIPAL

CONCEPTO	CARACTERÍSTICA PRINCIPAL	MARCADOR CLAVE
EMTC	Mezcla de varias patologías.	Anti-U1 RNP (+)
S. Sobreposición	Cumple criterios de 2 enfermedades distintas.	Variable (ej. Anti-DNA + Anti-Scl70)
E. Indiferenciada	Síntomas incompletos, no clasifica.	ANA (+) inespecífico

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Para el examen: Si te presentan un paciente con Raynaud, manos hinchadas y artritis, busca dirigidamente los **Anti-U1 RNP**. Si están presentes, la respuesta es Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente con artritis, fenómeno de Raynaud, disfagia y úlceras orales. Los anticuerpos anti-U1 RNP son positivos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- EMTC: mezcla de síntomas de artritis reumatoide, lupus, esclerodermia y miositis
- Marcador más importante: anticuerpos anti-ribonucleoproteína U1 (anti-RNP)
- Tratamiento similar al lupus
- No confundir EMTC (enfermedad definida con anti-RNP) con enfermedad indiferenciada del tejido conectivo (cuadro incompleto que evoluciona)
- Enfermedad indiferenciada: frecuentemente evoluciona a lupus o esclerodermia con el tiempo
- Síndrome de sobreposición: cumple criterios de dos patologías simultáneamente

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ENFERMEDAD MIXTA DEL TEJIDO CONECTIVO)

PREGUNTA 1

Paciente con artritis, fenómeno de Raynaud, disfagia y úlceras orales. Los anticuerpos anti-U1 RNP son positivos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Lupus eritematoso sistémico
- B) Esclerodermia difusa
- C) Enfermedad mixta del tejido conectivo
- D) Artritis reumatoide
- E) Síndrome de Sjögren

PREGUNTA 2

¿Cuál es la diferencia principal entre la enfermedad mixta y la enfermedad indiferenciada del tejido conectivo?

- A) La mixta no tiene anticuerpos y la indiferenciada sí
- B) La mixta es una entidad definida con anti-RNP; la indiferenciada es un cuadro incompleto que evoluciona
- C) La indiferenciada es más grave que la mixta
- D) La mixta solo afecta articulaciones
- E) No hay diferencia, son sinónimos

PREGUNTA 3

¿Hacia qué patología evoluciona más frecuentemente la enfermedad indiferenciada del tejido conectivo?

- A) Artritis reumatoide
- B) Vasculitis ANCA positivo
- C) Lupus eritematoso sistémico
- D) Fibromialgia
- E) Polimiositis

RESUMEN: ENFERMEDAD MIXTA DEL TEJIDO CONECTIVO

La enfermedad mixta del tejido conectivo (EMTC) es una mezcla de manifestaciones de artritis reumatoide (artritis), lupus (úlceras orales, rash malar, pericarditis, lupus cutáneo subagudo), esclerodermia (fenómeno de Raynaud, disfagia, esclerodactilia) y miositis (como en la polimiositis/dermatomiositis), pudiendo además complicarse con síndrome de Sjögren. El marcador más importante son los anticuerpos anti-ribonucleoproteína U1 (anti-RNP), cuya presencia apunta fuertemente al diagnóstico. El manejo es similar al del lupus. Es importante no confundir la EMTC con la enfermedad indiferenciada del tejido conectivo (EITC). La EMTC es una entidad propia con anticuerpos anti-RNP, mientras que la EITC es una forma inicial de enfermedad del tejido conectivo que aún no cumple criterios completos de ninguna patología específica. La EITC habitualmente evoluciona con el tiempo hacia lupus, esclerodermia u otra conectivopatía, aunque un porcentaje se mantiene indiferenciada. El síndrome de sobreposición ocurre cuando se cumplen criterios de dos patologías simultáneamente.